Processo nº 0062724-32.2025.8.17.2001

AUTOR(A): MARIA LUIZA BARACHO DA CUNHA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

# SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL INAUDITA ALTERA PARS, CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS**, proposta por **MARIA LUIZA BARACHO DA CUNHA** em face de **SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, todos devidamente qualificados, alegando, em síntese, que:

É segurada do plano de saúde da Ré, na modalidade "Produto 312", como dependente de sua genitora, titular do contrato há **28 anos**, mantendo-se adimplente com suas obrigações.

Em **abril de 2025**, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, após ser hospitalizada em **20 de abril de 2025** com queixas de alteração da visão. Exames de neuroimagem revelaram múltiplas lesões desmielinizantes, indicativas de alta carga lesional. Durante a internação, que durou até **27 de abril de 2025**, foi submetida a pulsoterapia com metilprednisolona.

Sua médica assistente, Dra. Silvana Sobreira Santos, prescreveu, em caráter de urgência, o início de terapia com o medicamento imunobiológico "Natalizumabe" (**TYSABRI**), na dosagem de **300 mg IV**, a ser administrado mensalmente, a fim de modificar o curso da doença e diminuir a possibilidade de sequelas definitivas.

Ao solicitar o custeio do tratamento à Ré, teve o pedido negado sob a justificativa de "não haveria cobertura contratual para o item solicitado". A autora afirma não possuir condições de arcar com o custo do medicamento, cujo valor de mercado varia entre **R$ 8.487,70** e **R$ 10.619,79**. Informa também que interpôs recurso administrativo junto à Ouvidoria da Ré em **09/07/2025**, mas não obteve resposta.

Argumenta que a recusa é abusiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aos contratos de plano de saúde, mesmo os anteriores à sua vigência. Sustenta que cláusulas que excluem tratamento essencial para garantir a saúde do beneficiário são nulas e que não cabe à operadora definir a terapêutica a ser utilizada.

Em face do exposto, requer o integral acolhimento da pretensão inicial para: i) **CONCEDER**, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para determinar que a Ré custeie e forneça integralmente o medicamento NATALIZUMABE, na dosagem de **300mg IV**, de forma mensal e por tempo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica; ii) Ao final, **CONFIRMAR** a tutela provisória, condenando a Ré à cobertura definitiva do tratamento; iii) **CONDENAR** a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de **R$ 15.000,00** (quinze mil reais).

Requereu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00.

Na decisão de ID 211273595, o valor da causa foi corrigido de ofício para **R$ 31.366,08**, correspondente à soma de uma anuidade do contrato (**R$ 16.366,08**) com o valor do pedido de danos morais (**R$ 15.000,00**). O pedido de justiça gratuita foi deferido parcialmente, com a redução das custas processuais iniciais em **50%**.

O pedido de Tutela Provisória de Urgência foi deferido no ID 211273595, com a seguinte redação:

> "Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que a Ré, SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, no prazo de até 5 dias, autorize e custeie, na forma do contrato, o fornecimento integral do medicamento NATALIZUMABE (TYSABRI), em dosagem de 300mg IV, de forma mensal, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada por este Juízo, sem prejuízo das medidas indutivas e coercitivas dispostas no Art.139, IV, do CPC."

**SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE** apresentou contestação no ID 213861504, em que, preliminarmente, aduz:

> a) **Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC):** Argumenta que a alegação da autora não é verossímil, pois o procedimento solicitado não possui cobertura contratual, e que a decisão foi proferida de forma equivocada.
>
> b) **Ausência de perigo da demora:** Sustenta que os documentos acostados aos autos não demonstram que a medida possui caráter de urgência, o que afastaria um dos requisitos para a concessão da liminar.

No mérito, afirma:

> a) **Inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e do Rol da ANS:** Defende que o contrato foi firmado antes da vigência da referida lei e não foi adaptado, devendo ser regido por suas cláusulas originais, em respeito ao ato jurídico perfeito. Cita o Tema 123 do STF (RE nº 948.634/RS), que estabelece a inaplicabilidade da lei nova aos contratos antigos não adaptados.
>
> b) **Exclusão contratual para medicamento de uso ambulatorial/domiciliar:** Alega que o tratamento pleiteado caracteriza-se como despesa não coberta, pois o contrato exclui o fornecimento de medicamentos fora do regime de internação hospitalar.
>
> c) **Licitude da recusa:** Afirma que a negativa de cobertura constituiu exercício regular de direito, uma vez que está amparada nas cláusulas contratuais e na legislação vigente à época da contratação, não havendo qualquer abusividade na conduta.

d) **Inexistência de dano moral:** Assevera que a recusa foi legítima e baseada no contrato, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de divergência contratual, o que não configura dano moral indenizável.

e) **Impossibilidade de inversão do ônus da prova:** Argumenta que não estão presentes os requisitos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações que autorizariam a inversão do ônus probatório.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar.

Decido.

**1. Do julgamento antecipado da lide.**

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do Art.355, I, do Diploma de Ritos. É que, compulsando os elementos produzidos pelas partes, se infere desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental apresentada. Eventual produção de prova oral ou pericial não terá o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que o julgador, visualizando nos autos elementos suficientes para a apreciação das questões postas pelas partes, pode dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, e julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, p. 397).

Nessa diretiva, Cândido Rangel Dinamarco é preciso ao pontuar: “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do Art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. São Paulo: Malheiros, p.555).

Na mesma linha de raciocínio, o STF firmou entendimento de que "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (STF - RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984, p.20990). Para a Corte, "o propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado (STF -RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer).

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, **não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção**. Desse modo, não há incompatibilidade entre o Art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o Art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
>
> PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - **Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, Art.130, parte final).2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado**

> **antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa**. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe29/06/2011).

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ. REsp nº2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, QUARTA TURMA). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

**2. Mérito**

A controvérsia dos autos reside em definir quanto à legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito pela médica assistente, **Natalizumabe (TYSABRI) 300mg IV**, bem assim se da negativa administrativa resultou dano extrapatrimonial indenizável.

Consoante emerge dos elementos coligidos, o relacionamento obrigacional estabelecido entre as partes se iniciara antes da vigência da lei dos planos de saúde e, sem notícia de sua adaptação, vige até os dias atuais. Destarte, diante do fato de que o contrato é antigo e não houve adaptação à Lei 9.656/98, deve, de regra, prevalecer o livremente pactuado.

Como cediço, o ato jurídico perfeito é resguardado como inerente à irretroatividade legislativa pelo próprio legislador constitucional. Assim, em se tratando de contrato antigo e não adaptado, não está sujeito à incidência da lei dos planos de saúde, pois lhe é posterior.

Ressalte-se que, em julgamento recente, datado de fevereiro de 2018, o Plenário do **Supremo Tribunal Federal** julgara parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº 1931/DF, que questionava a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), considerando válida a maioria dos dispositivos questionados, entendendo, contudo, que **os contratos celebrados antes da**

**vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde que encartara**. Em tal abordagem, os artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998 e o artigo 2º da MP 2.177-44/2001, foram declarados inconstitucionais. Ressalve-se que o acórdão fora publicado em 1º de agosto de 2018[1].

> "Cumpre ressaltar, destarte, o que dispunham os artigos declarados inconstitucionais, adiante transcritos, para compreensão da matéria em exame:
>
> "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Art. 12 desta Lei, exceto:
>
> (...) § 2 As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1º, do Art. 10 desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores."
>
> (...)
>
> "Art. 35-E. **A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que**:
>
> I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
>
> III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do Art. 1º desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do Art. 13 desta Lei;
>
> IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
>
> § 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:

> I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único do Art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada;
>
> II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior (...)." (grifos nossos)

Frisou o Supremo Tribunal Federal, em síntese, que os dispositivos reputados desconformes previam a incidência de novas regras relativas aos planos de saúde aos contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), criando parâmetros completamente distintos daqueles que foram objeto da contratação, violando, com isso, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, estabelecidos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, devendo-se observar, ademais, o princípio da segurança jurídica, que não autoriza o afastamento de ato jurídico perfeito mediante aplicação de lei nova. De relevo anotar que o eminente relator da ação declaratória de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, deixou acentuado, ao final da argumentação que, à guisa de tutelar o direito do consumidor, o legislador exorbitara o autorizado pela Constituição Federal, substituindo a vontade dos contratantes, incorrendo em inconstitucionalidade, *verbis*:

> "(...) **Os dispositivos em análise preveem a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma. A norma destoa do Texto Maior. A vida democrática pressupõe segurança jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova. É o que decorre do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal**:
>
> Art. 5º [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
>
> É impróprio inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação de

vontade.

(...)

**A toda evidência, o legislador, com o intuito de potencializar a proteção do consumidor, extrapolou as balizas da Carta Federal, pretendendo substituir-se à vontade dos contratantes. Salta aos olhos a inconstitucionalidade. Ante o quadro, reafirmo o entendimento externado no exame do pedido liminar, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998, bem assim do artigo 2º da Medida Provisória nº2.177-44/2001**."

Sob essas premissas, celebrado o contrato que enlaça as litigantes antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, ressaltando-se o fato de que o contrato é antigo e não há notícia de sua adaptação à lei dos planos de saúde, deve-se observar o pactuado originalmente.

A hipótese de o contrato ter sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, a luz do que sufragado pelo E. STJ, não constitui razão suficiente para afastar a sua incidência. Isso porque:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. **RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA**. (...) 2.- **Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.** (...) (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 323.519/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012)

Não sem razão, quando da edição da Súmula nº 608, o colendo STJ estabeleceu, sem ressalvas cronológicas, que "**aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,**

**salvo os administrados por entidades de autogestão**" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe17.04.2018; na mesma oportunidade, cancelou-se a Súmula nº 469).

Estabelecida a premissa de que a análise da controvérsia deverá observar o regramento estabelecido no contrato e as disposições do código consumerista, verifica-se que a controvérsia apresentada no feito gravita em torno da abusividade ou não da cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamentos não ministrados em regime de internação hospitalar ou em tratamento ambulatorial, quando a medicação prescrita é a única eficaz para o tratamento da doença que acomete o beneficiário.

Da análise do contrato juntado aos autos (IDs 210993485 e 210993486), verifica-se que a apólice estabelece cobertura para "INTERNAÇÕES HOSPITALARES" e "SERVIÇOS AMBULATORIAIS". Especificamente, a cláusula 4.1, alínea 'e', prevê a cobertura de "medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusão e demais recursos terapêuticos ministrados durante o período de internação hospitalar":

> **4 - COBERTURAS DO SEGURO**
>
> A Seguradora reembolsará ao segurado, dentro dos limites do plano contratado, as despesas relativas a:
>
> **4.1 - INTERNAÇÕES HOSPITALARES, abrangendo**:
>
> a) diárias, sem limite;
>
> b) serviços gerais de enfermagem;
>
> c) alimentação;
>
> d) exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença, realizados após a internação hospitalar e até a data da alta hospitalar;
>
> e) **medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusão e demais recursos terapêuticos ministrados durante o período de internação hospitalar**;
>
> f) taxa de sala de operação, inclusive material utilizado, de acordo com o porte cirúrgico;
>
> g) unidade de terapia intensiva ou isolamento, quando e enquanto determinado pelo médico-assistente;

h) remoção do paciente, quando comprovadamente necessário, em território brasileiro;

i) sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme a prescrição do médico assistente;

j) despesas de acompanhantes, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos;

De igual forma, a cláusula 4.2.3 prevê cobertura para "medicamentos e materiais cirúrgicos, exclusivamente aqueles utilizados no atendimento ambulatorial":

**4.2 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS, abrangendo:**

**4.2.1 - Consultas Médicas**

Consultas médicas prestadas em consultórios, ambulatórios ou pronto-socorros, por clínicos ou especialistas legalmente habilitados.

Consultas médicas domiciliares, nos casos de urgência ou emergência comprovados por relatório do médico assistente.

**4.2.2 - Diagnose e Terapia**

Desde que estes procedimentos tenham sido requisitados pelo médico assistente.

**4.2.3 - Outros Serviços Ambulatoriais, abrangendo:**

- cirurgia de pequeno porte que dispense internação hospitalar ou atendimento de pronto-socorro;

- **medicamentos e materiais cirúrgicos, exclusivamente aqueles utilizados no atendimento ambulatorial**;

- remoções em ambulância, desde que solicitadas e justificadas pelo médico assistente.

A negativa da seguradora, por sua vez, parece amparar-se na cláusula 6.14, que exclui da cobertura "Vacinas preventivas e auto vacinas; **medicamentos e materiais cirúrgicos, exceto aqueles utilizados durante o regime de internação hospitalar ou durante o tratamento ambulatorial**.”.

Ora, a própria cláusula de exclusão invocada pela ré é a que ampara a pretensão autoral. A norma contratual não veda a cobertura de medicamentos de forma genérica, mas apenas daqueles de uso

domiciliar. O que se discute nestes autos é o custeio de um fármaco que, por sua natureza e complexidade, não pode ser autoadministrado, exigindo, para sua aplicação, estrutura clínica especializada e supervisão médica.

O Laudo Médico de ID 210991832 é claro ao prescrever o "Natalizumabe" na dosagem de "300 mg IV, mensal", ou seja, por via intravenosa, procedimento que, por óbvio, não se realiza em ambiente domiciliar, mas sim ambulatorial ou hospitalar. Tal fato é corroborado pela própria bula do medicamento, que, conforme bem pontuado na decisão liminar, determina que o tratamento deve ser "iniciado e continuamente supervisionado por um médico especialista com experiência em diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, em centros com fácil acesso a imagens de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)" e administrado "por infusão intravenosa ao longo de 1 hora", recomendando-se a observação do paciente por mais uma hora após o procedimento.

Desta forma, o tratamento prescrito à autora enquadra-se perfeitamente nas exceções previstas na cláusula 6.14 do contrato, ou seja, "medicamentos (...) utilizados durante o regime de internação hospitalar ou durante o tratamento ambulatorial". A recusa, portanto, mostra-se contrária ao próprio instrumento contratual.

Em consulta à bula do medicamento[2], verifica-se que:

> "**8) POSOLOGIA E MODO DE USAR**
>
> O tratamento com TYSABRI™ (natalizumabe) deve ser iniciado e continuamente **supervisionado por um médico especialista com experiência em diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, em centros com fácil acesso a imagens de Ressonância Magnética Nuclear** (RMN)."
>
> "A solução diluída deve ser administrada por **infusão intravenosa ao longo de 1 hora** (...)
>
> "Método e via de administração:
>
> TYSABRI™ (natalizumabe) apresenta-se sob a forma de solução concentrada que deve ser diluída em solução de cloreto de sódio a 9 mg/mL (0,9%) antes da

> administração por **infusão intravenosa**.
>
> (...) recomenda-se que **o paciente fique em observação durante a infusão e durante a hora seguinte ao procedimento**. Todos os recursos para o tratamento de hipersensibilidade devem estar disponíveis no local da infusão, **bem como o acesso a imagens de Ressonância Magnética Nuclear**."

A bula é explícita ao determinar que a administração deve ocorrer em um ambiente especializado e sob supervisão médica, não podendo ser realizada em domicílio. Portanto, a recusa da ré em custear o medicamento "Natalizumabe (TYSABRI)" mostrou-se ilícita, por violação expressa ao contrato e às normas de proteção ao consumidor.

**2.1 Dos Danos Morais Alegados**

Assiste razão à autora quando pugna por verba indenitária compensatória em razão dos danos morais resultantes de conduta da demandada.

O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que, para além da sua específica condição debilitada se vê abandonado e desguarnecido da proteção contratualmente acertada, inegavelmente configura hipótese de ofensa ao seu patrimônio imaterial.

Como já assinalado, o caso é de inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, respondendo a ré de forma objetiva perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do código consumerista.

É consabido que a Política Nacional das Relações de Consumo objetiva atender às necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, a sua saúde e a sua segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia a elas inerentes, nos termos do Art. 4º, *caput* do CDC. Os princípios inerentes a essa política protecionista estão insculpidos nos diversos incisos do Art. 4º do CDC. Dentre eles evidencio: (i) o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (Art. 4º, I, do CDC); (ii) a harmonização dos sujeitos das relações de consumo,

sempre com base na boa-fé e no equilíbrio (Art. 4º, III, do CDC); (iii) a informação adequada, com vistas à melhoria do mercado de consumo (Art. 4º, IV, do CDC) e (iv) a coibição e à repressão eficiente de todos os abusos nele praticados (Art. 4º, VI, do CDC).

Nessa senda, associado ao exercício da livre iniciativa fundada em valores sociais (arts. 1º, IV; 170, *caput* e V; e 173, § 4º, da Constituição da República), é dever irrenunciável da demandada ser transparente e agir de boa-fé (objetiva), assegurando o equilíbrio nas relações de consumo com o atendimento das necessidades dos seus contratantes.

A proteção à saúde como direito básico dos consumidores é um dos sustentáculos da dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurada e dirige-se à realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, a liberdade, a justiça e a solidariedade.

Nesse contexto, quando a seguradora ré se nega a fornecer ou a autorizar, procedimentos, medicamentos, exames diagnósticos e materiais demandados pela equipe médica no período em que o segurado se encontra fragilizado física e psiquicamente em razão do adoecimento afigura-se como prática abusiva, fundada no abuso de poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor.

No caso em tela incide a teoria do risco do empreendimento que reclama responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, evidenciada pela inobservância dos deveres de lealdade, transparência e boa-fé que devem nortear as relações de consumo, no cumprimento do contrato, de modo a acarretar transtornos capazes de ensejar ofensa ao patrimônio subjetivo do segurado.

A indevida negativa de autorização de procedimento, sem causa fática ou legal que a legitime, constitui abuso de direito que se amolda ao enunciado do artigo 186 do Código Civil e por isso é ato ilícito, ensejador de reparação através dos critérios compensatórios e sancionatórios,

visando à recomposição do patrimônio moral violado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido.

A jurisprudência, com a qual me filio, em situações análogas não tem trilhado caminho diverso:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS CIVIS. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS THACOSIL E COLA BIOLÓGICA NECESSÁRIOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO**. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se de entidade caracterizada pela autogestão e sem fins lucrativos, limitada a funcionários do Banco do Brasil S/A e seus parentes, ou seja, sem atuação no mercado de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608.2. Todavia, ainda que afastada a aplicação do Código Consumerista, é fato que os princípios contratuais previstos na legislação civilista devem ser observados, notadamente a função social dos contratos (Art. 421) e os princípios da probidade e boa-fé objetiva (Art. 422), além da interpretação mais favorável ao aderente, em casos de contratos de adesão (Art. 423).3. Analisando as razões trazidas aos autos, entende este Colegiado que a tese defendida pelo plano de saúde apelante não é suficiente para justificar a não viabilização imediata do procedimento terapêutico requisitado, pois, considerando que a disponibilização de tratamentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do segurado constitui a própria essência do contrato de seguro saúde, qualquer atitude tomada pela operadora de plano de saúde que obstaculize a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, se mostra, a toda evidência, contrária à própria natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual, sendo, por isso, ilícita. 4. É obrigação da seguradora de saúde autorizar o serviço de saúde da maneira como requerido pelo médico assistente, por ser ele detentor de capacidade técnica para justificar a sua indicação e responsável por

ponderar se o tratamento é capaz de influir na cura da paciente, podendo apenas o plano de saúde eleger que doenças estarão ou não abrangidas pela sua cobertura. Precedentes. 5. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no seu espírito. Casos de negativa de cobertura contratual por parte da operadora de saúde não pode ser visto como mero inadimplemento ou discussão contratual, caracterizando dano moral. Precedentes jurisprudenciais. 6. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não trouxe informações capazes de rechaçar cabalmente as alegações do ator/apelado, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto pelo Art. 373, II, do CPC e sendo assim o reembolso integral das despesas contraídas pelo recorrido com o material cirúrgico deve ser deferido, tal como entendeu o juiz a quo não merecendo reparo sua decisão no tocante aos danos materiais sofridos.7. Em sessão, deliberando-se acerca do quantum indenizatório e tomando por base os pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade que devem permear a fixação da indenização por danos morais, considerou o Colegiado como razoável a redução do valor arbitrado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 8. Recurso parcialmente provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE, Apelação Cível 0000092-19.2013.8.17.1280 (545551-4), Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior. Data do Julgamento: 05/02/2020). (Destaquei)

PLANO DE SAÚDE – SEGURADO – CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – DESCONSIDERAÇÃO – Os contratos celebrados para assistência à saúde, se identificam como de prestação de serviço e devem obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor no que respeita às cláusulas ditas abusivas, como o são aquelas que colocam o usuário do serviço em desvantagem exagerada em relação àquele que os presta; a inadimplência de sessenta dias que autoriza a suspensão do contrato é aquela é a contínua e não a que soma pequenos dias de atrasos alternados ocorridos ao longo do pacto. **Constatado que o segurado estava com suas prestações atualizadas, a recusa em atendê-lo quando necessitou do serviço, é certa que lhe acarretou prejuízos de natureza moral e material, esta, quando ele teve que desembolsar recursos próprios para tratar-se de sua enfermidade**; o dano material é o que ficou, objetivamente, provado, enquanto que o dano moral, que tem natureza subjetiva, deve ser arbitrado, segundo as circunstâncias do caso, suas consequências, partes envolvidas, tendo sempre

> presente que a condenação, que reverterá em favor do ofendido, tem caráter educativo, e, por isso, há que ser arbitrada de modo a não se revelar insignificante, e, por outro lado, não deve ser tão elevada para não se converter em locupletamento (TJMA – AC 019119/2002 – (44.287/2003) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Stélio Muniz – J. 24.04.2003). (Destaquei)

Nesse cenário, a condenação da ré a compensar os danos de ordem imaterial suportados pela demandante se impõe, a partir de uma estimação prudencial que leve em consideração o grau em que o prejuízo causado influiu no seu ânimo e no seu sentimento:

A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade. (TJRJ - 8ª C. - Ap. - Rel. Silveira Neto - j. 29.10.92 - JTJ- LEX 142/104).

A vítima de lesão de direitos de natureza não patrimonial (Constituição da República, Art. 5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP - 7º Rel. Campos Mello j. 30.10.91 RJTJESP 137/187).

A reparação, nesse panorama, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatados de acordo com as peculiaridades que envolvem o pleito (STJ - RESP 200500465226 - (736968) - RJ - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 01.07.2005 - p. 00559).

Dito isto, em atenção aos critérios e princípios acima elencados e consideradas as peculiaridades do caso em comento, tenho que, diante das provas documentais constantes dos autos, houve perceptível inobservância da indispensável equidade da mesma no desenvolvimento do trato contratual avençado, propiciando plenas condições à respectiva ocorrência.

Concernente às repercussões do fato danoso, tenho-os como relevantes para abalar a personalidade da autora, principalmente por ocorrer no momento em que esta necessitava do devido respaldo econômico e de tranquilidade para se recuperar.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso em questão e tendo em vista os princípios de moderação e razoabilidade, entendo ser justo e necessário fixar o importe compensatório pertinente em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo tal imposição plenamente justificável para que de um lado se tenha a devida compensação pelos transtornos passados pela autora e, de outro, medida verdadeiramente pedagógica, pois destinada a de tentar evitar a reiteração da conduta perpetrada pela demandada, explicitamente prejudicial aos seus contratantes, consumidores.

**3. Dispositivo**

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão entabulada na exordial para, confirmando a tutela de urgência deferida (ID 211273595), **CONDENAR** a empresa ré a **custear** o tratamento da autora com o medicamento **NATALIZUMABE (TYSABRI)**, na forma prescrita pelo seu médico assistente; e **pagar**, a título de compensação por danos morais, o valor de **R$ 8.000,00 (oito mil reais)**, a ser atualizado pelo **IPCA** a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora a contar da citação. Por ter a citação ocorrido já na vigência da Lei 14.905/2024, os juros moratórios corresponderão à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Condeno a demandada a pagar custas e honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.

**No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios** (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado), aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da

causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

**Interposta a apelação**, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (Art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito, arquivem-se os autos definitivamente.

**Via eletronicamente assinada servirá como expediente de comunicação processual.**

Recife (PE), 26 de agosto de 2025.

**José Júnior Florentino dos Santos Mendonça**

**Juiz de Direito**

**1**

---

[1] Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1741189. Acesso em 07/04/2020, às 12:05.

[2] https://br.biogen.com/content/dam/corporate/americas/brazil/pt-br/pdf-medicines/tysabri_natalizumabe_bula_profissional.pdf

Assinado eletronicamente por: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA
26/08/2025 09:25:17
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 214090873

25082609251783600000208418066

IMPRIMIR GERAR PDF